

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	TATALAKSANA HIV (DIAGNOSIS HIV, TERAPI ARV, TATALAKSANA TBC-HIV DAN PEMANTAUAN PENGOBATAN ARV)		
	No. Dokumen 2. 351.17/I-SPO/HIV/VI/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 11

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 20 Juni 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes
Pengertian	1. Infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus HIV, yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus HIV dapat ditularkan melalui: hubungan seksual (anal atau vagina) tanpa pelindung (kondom), transfusi darah dan transplantasi organ dari orang yang terinfeksi HIV, penggunaan jarum yang terkontaminasi, dan transmisi vertikal dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayinya selama kehamilan, persalinan dan menyusui. 2. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) merupakan infeksi HIV stadium lanjut, yang terjadi apabila infeksi HIV tidak diobati dengan obat Antiretroviral (ARV). 3. Pengobatan Antiretroviral (ARV) merupakan pemberian terapi pada pasien yang telah didiagnosa mengidap Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau disebut dengan ODHIV atau orang dengan HIV pada fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan sebagai layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP) untuk mendapatkan pengobatan Antiretroviral (ARV). 4. Layanan PDP merupakan 5. layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan ODHIV. 6. Tuberkulosis, atau yang sering disingkat TBC, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. 7. TBC aktif adalah kondisi dimana infeksi TBC yang sebelumnya tidak menunjukkan gejala penyakit yang ditimbulkan seperti batuk yang berlangsung lama, demam, dan penurunan berat badan, berkeringat malam hari tanpa aktivitas berarti, pembesaran kelenjar getah bening. 8. Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) adalah pengobatan yang diberikan kepada seseorang yang terinfeksi bakteri	

	Mycobacterium tuberculosis dan berisiko berkembang menjadi TBC aktif serta pada populasi ODHIV yang terbukti tidak sakit TBC aktif. 9. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit tuberkulosis (TBC), baik TBC sensitif obat maupun TBC resistan obat (TBC RO). OAT terdiri dari obat lini pertama dan obat lini kedua, tergantung pada jenis TBC dan hasil uji sensitivitas obat. 10. Infeksi laten tuberkulosis sebuah keadaan respon imun yang persisten dalam menstimulasi antigen Mycobacterium tuberculosis dengan tanpa adanya manifestasi klinis TB aktif.
Tujuan	Sebagai acuan teknis terkait penatalaksanaan ODHIV secara komprehensif dimulai dari tahap tes HIV, diagnosa, pengobatan, tatalaksana TBC-HIV, pemantauan efek samping, serta keberhasilan terapi ARV.
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 895.2/I-PDM/HIV/X/2025 tentang Pedoman Pelayanan HIV/AIDS
Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>, dan Infeksi Menular Seksual; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/90/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana HIV 3. Petunjuk Teknis Penanganan Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTb), Kementerian Kesehatan, 2020 Petunjuk Teknis Kolaborasi TBC-HIV. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.2023
Prosedur/ Langkah-langkah	1. Persiapan alat dan bahan : - Perangkat komputer dan sejenisnya - Aplikasi SIHA 2.1 - Alat pemeriksaan Tanda-tanda Vital (TTV) (Sfigmomanometer, Termometer, Stetoskop, Pulse Oksimetri) - Alat pemeriksaan lainnya (misal: Timbangan badan, <i>Pen Light, Tongue Spatel</i>, dll) - Pemeriksaan laboratorium (diagnostik test) - Rapid Test - Buffer - Mikropipet ukuran 5-50 µl beserta tip pipet yang sesuai atau pipet kapiler yang disediakan dalam kemasan - Tabung vacutainer - Tabung EDTA - Holder vacutainer - Tourniquet - Kapas alkohol - Sarung tangan - Timer

	f. Pemeriksaan laboratorium lainnya (sesuai indikasi pemeriksaan klien di layanan) g. Hasil pemeriksaan laboratorium h. Rekam Medis (Cetak/Elektronik) i. Ikhtisar keperawatan pengobatan HIV (optional) j. Kartu pasien HIV 2. Petugas yang melaksanakan Layanan PDP HIV : a. Dokter b. Perawat c. Analis laboratorium d. Petugas Farmasi e. Petugas Data/ RR 3. Langkah - langkah : a. Alur Pemeriksaan Tes HIV i. Klien datang ke ruang pendaftaran/administrasi dengan membawa KTP. Selain datang secara mandiri melalui rawat jalan, klien tes HIV juga dapat berasal dari rawat inap atau poli lain sesuai bagan alir terlampir (Lampiran1). ii. Petugas pendaftaran melakukan pencatatan data berupa: nama lengkap, NIK, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, nomor telepon aktif, atau variabel lain yang dibutuhkan menyesuaikan sistem informasi yang ada di fasyankes. iii. Setelah pendaftaran selesai, petugas pendaftaran mengarahkan klien ke ruang konseling/pemeriksaan. iv. Di ruang konseling/pemeriksaan, dokter/perawat memberikan penjelasan mengenai: 1. Tes HIV dan manfaatnya, 2. Prosedur pengambilan sampel untuk pemeriksaan HIV, 3. Kemungkinan hasil dari tes yang dilakukan. v. Dokter/perawat meminta persetujuan verbal (verbal consent) dari klien untuk menjalani tes HIV. 1. Jika klien memberikan persetujuan, maka klien akan diarahkan ke laboratorium untuk pengambilan sampel. 2. Jika klien menolak, maka klien akan diminta menandatangani surat penolakan tindakan. <i>Format surat penolakan dapat disesuaikan dengan format yang berlaku di masing-masing layanan.</i> Dokter tetap memberikan kembali informasi tentang manfaat pemeriksaan HIV kepada klien. vi. Di ruang laboratorium, petugas laboratorium melakukan pengambilan sampel darah dan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan HIV.
--	---

	vii. Petugas laboratorium menyerahkan hasil tes HIV kepada Dokter/Perawat di ruang konseling/pemeriksaan atau menginput melalui sistem rekam medis elektronik yang tersedia viii. Di ruang konseling/pemeriksaan, Dokter melakukan verifikasi kembali identitas klien sebelum membuka hasil tes. ix. Dokter membuka dan menyampaikan hasil tes HIV langsung kepada klien. x. Dokter menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil tes. 1. Hasil Negatif. Dokter/Perawat memberikan paket layanan untuk hasil negatif, yang mencakup: - Penjelasan mengenai arti hasil negatif; - Edukasi dan pemberian kondom; - Jika klien berisiko tinggi atau merupakan populasi kunci, maka petugas juga akan memberikan informasi dan menawarkan terkait ketersediaan modalitas pencegahan HIV, seperti: Pre-exposure Prophylaxis (PrEP), Layanan Alat Suntik Steril (LASS) dan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM), serta layanan sirkumsisi, baik pada fasyankes tersebut secara mandiri jika tersedia atau dirujuk ke fasyankes lain. - Anjuran untuk melakukan tes HIV secara rutin, terutama bagi kelompok berisiko tinggi. 2. Hasil Positif Dokter memberikan paket layanan untuk klien HIV positif, meliputi: - Penatalaksanaan Infeksi Oportunistik (IO) dan penapisan Infeksi Menular Seksual (IMS); - Pemberian profilaksis kotrimoksazol dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT); - Pengobatan IMS serta penapisan penyakit lain seperti TBC, Hepatitis B (VHB), dan Hepatitis C (VHC)*; - Skrining kesehatan jiwa; - Edukasi tentang kepatuhan minum obat (KIE); - Notifikasi pasangan dan anak; - Permintaan <i>informed consent</i> untuk penelusuran klien (<i>contact tracing</i>); - Tes kehamilan dan perencanaan kehamilan (jika diperlukan); - Pemberian ARV sesuai pedoman nasional; - Pemantauan pengobatan ARV secara berkala.
--	--

	^{*)}: <i>disesuaikan dengan ketersediaan di layanan</i> 3. Hasil Inkonklusif - Dokter menyarankan klien untuk melakukan tes ulang dalam 2 minggu. - Jika hasil tes ulang negatif atau kembali inkonklusif, Dokter menyimpulkan hasil sebagai negatif dan memberikan paket layanan untuk hasil negatif. - Jika hasil tes ulang positif, maka Dokter memberikan paket layanan untuk klien HIV positif, disesuaikan dengan kondisi masing-masing klien. xi. Pencatatan dan Pelaporan. Petugas (Dokter/Perawat dan RR) akan menginput data klien ke dalam Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) 2.1: - Tambah pasien baru, input NIK dan nama lengkap sesuai identitas asli (KTP); - Verifikasi apakah klien sudah terdaftar sebelumnya di layanan PDP; - Input permintaan pemeriksaan laboratorium oleh Dokter dan hasil tes (selanjutnya diisi oleh Petugas Laboratorium); - Setelah hasil keluar, data dikirimkan ke Dokter untuk pembukaan status klien. - Dokter menginputkan hasil diagnosis dari hasil pemeriksaan lab. - Selain SIHA, data pemeriksaan dan hasil tes HIV juga akan diinput ke dalam rekam medis elektronik layanan. b. Tata Laksana HIV Positif pada Klien Dewasa - Dokter melakukan pemeriksaan awal yang mencakup: - Anamnesis dan pemeriksaan fisik; - Jika diperlukan dokter akan memintakan pemeriksaan laboratorium tambahan, seperti misalnya pemeriksaan fungsi ginjal pada klien baru dengan kecurigaan gangguan fungsi ginjal atau memiliki komorbid hipertensi atau diabetes mellitus tidak terkontrol; - Jika tersedia pemeriksaan CD4 dan klien bersedia, maka dokter akan memintakan pemeriksaan untuk melihat apakah klien termasuk pasien stadium lanjut atau dini. Jika angka CD4 <200 sel/mm³, maka klien dikategorikan pasien HIV stadium lanjut atau <i>Advance HIV Disease</i> (AHD) dan akan diberikan profilaksis kotrimoksazol.
--	--

4. Jika pemeriksaan CD4 tidak tersedia atau tidak bisa dilakukan, maka penentuan stadium pasien dilakukan berdasarkan kriteria stadium klinis. (Lampiran 2)
 5. Dokter juga akan melakukan penapisan untuk mengidentifikasi infeksi oportunistik (IO) lain serta melakukan tata laksana standar;
 6. Melakukan penapisan tuberkulosis (TBC) aktif menggunakan pertanyaan 4 gejala dan 1 tanda, yaitu; batuk, demam hilang timbul, keringat malam tanpa aktivitas, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas, serta gejala dan tanda TBC ekstra paru, misalnya: pembesaran KGB di leher, ketiak dan lain-lain.
 7. Melakukan penapisan infeksi menular seksual (IMS) lainnya baik melalui pendekatan sindrom atau pendekatan laboratorium jika tersedia.
- ii. Dokter memberikan terapi ARV sesuai hasil pemeriksaan klien. Pemberian terapi ARV dapat dilakukan di hari yang sama, dengan regimen mengacu kepada Permenkes No.23 Tahun 2022, yakni sebagai berikut:

Kondisi	Regimen Pilihan	Regimen Alternatif
A. Semua ODHIV dewasa dan remaja yang memulai terapi ARV	TDF+3TC+DTG	TDF+3TC+EFV ⁶⁰⁰ TDF+3TC+EFV ⁴⁰⁰
B. Koinfeksi TBC	TDF+3TC+EFV ⁶⁰⁰	TDF+3TC+DTG dengan penambahan 1 tablet DTG 50 mg dengan jarak 12 jam

- iii. Namun, ada beberapa kondisi pemberian ARV harus ditunda, yaitu dalam kondisi berikut:
1. Infeksi HIV yang disertai infeksi toksoplasmosis maka pemberian terapi ARV diberikan setelah 2 minggu sejak pemberian pengobatan toksoplasmosis.
 2. Infeksi HIV yang disertai infeksi kriptokokus, pengobatan ARV maka diberikan setelah 4-6 minggu sejak pemberian terapi kriptokokus.
 3. Infeksi HIV yang disertai infeksi TBC aktif, maka pengobatan TBC dimulai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan ARV sesegera mungkin dalam 2 minggu pertama pengobatan TBC tanpa memandang nilai CD4.
 4. Pada kasus infeksi TBC meningitis, terapi ARV ditunda minimal setelah 4 minggu (dan terapi ARV dimulai dalam 8 minggu) setelah pengobatan TBC.
- iv. Dokter memberikan TPT atau Terapi Pencegahan TBC jika hasil penapisan TBC negatif dan klien tidak memiliki

kontraindikasi terhadap TPT (sesuai bagan alir Lampiran 3). Pilihan paduan TPT yang direkomendasikan pada ODHIV seperti terlihat tabel berikut :

6H	3HP*
1. Isoniazid (INH) setiap hari selama 6 bulan (1 bulan = 30 hari pengobatan) 2. Dosis INH adalah 10 mg/kgBB/hari (maksimal 300 mg/hari) Umur <10 tahun: 10 mg/kg BB Umur ≥10 tahun: 5 mg/kg BB 3. Obat dikonsumsi satu kali sehari, sebaiknya pada waktu yang sama (pagi, siang, sore atau malam) saat perut kosong (1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan) 4. Diberikan Vitamin B6 25 mg/hari atau 50 mg selang sehari atau 2 hari sekali	1. Pemberian Isoniazid (INH) dan Rifapentine setiap minggu selama 3 bulan 2. Dosis INH adalah 15 mg/kgBB/minggu (maksimal 900 mg/minggu) 3. Dosis Rifapentine adalah 25 mg/kgBB/minggu (maksimal 900 mg) 4. Diberikan setiap minggu selama 12 minggu dengan total 12 dosis 5. Diberikan vitamin B6 25 mg tiap pemberian INH dan rifapentin 6. Belum direkomendasikan untuk wanita hamil 7. Wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal harus disarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi penghalang tambahan seperti kondom, kap serviks, <i>contraceptive sponge</i>, diafragma untuk mencegah kehamilan 8. Tidak diminum bersamaan dengan nevirapine (NVP) 9. Dapat diberikan bersamaan dengan makanan kecuali buah-buahan atau dalam keadaan lambung kosong

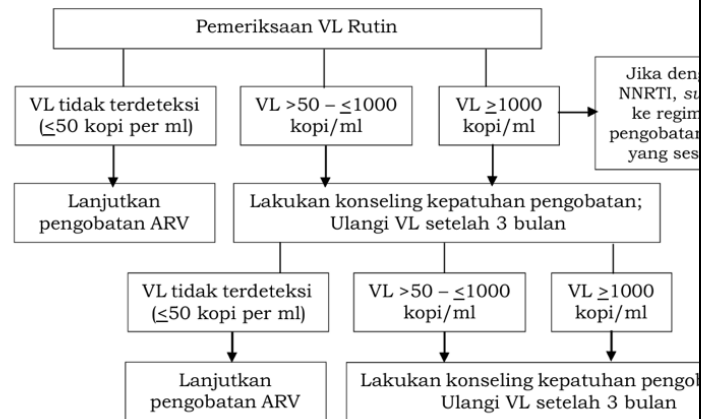
* Obat ini tidak direkomendasikan penggunaannya pada anak berusia <2 tahun dan ibu hamil karena hingga saat ini belum ada data terkait keamanan serta farmakokinetik dari rifapentine.

- v. Dokter merujuk klien dengan hasil skrining TBC positif untuk melakukan pemeriksaan diagnosis TBC (TCM/PCR). Pada klien dengan hasil penapisan TBC positif, pemberian ARV ditunda dulu sampai tegak diagnosis TBC klien. Jika klien terdiagnosis TBC, maka pengobatan TBC dimulai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan ARV sesegera mungkin dalam 2 minggu pertama pengobatan TBC tanpa memandang nilai CD4.
- vi. Jika hasil pemeriksaan diagnosis TBC klien negatif, maka berikan ARV dan TPT.
- vii. Dokter memberikan Pengobatan Pencegahan Kotrimoksazol (Profilaksis Kotrimoksazol) dengan dosis 1x960mg kepada klien dengan nilai CD4 <200 sel/mm³, atau klien dengan stadium klinis III atau IV, untuk pencegahan beberapa penyakit infeksi oportunistik, yaitu *Pneumonia jirovecii* (PCP), Toxoplasmosis, Salmonellosis, *Isospora belli*, dan malaria bagi pasien yang tinggal di daerah endemis malaria.
- viii. Pemberian profilaksis kotrimoksazol akan dihentikan setelah klien mengkonsumsi ARV minimal 6 bulan dengan nilai CD4 > 200 sel/mm³ dua kali berturut-turut dengan interval 6 bulan, atau jika tidak tersedia hasil pemeriksaan CD4 di layanan akan dilanjutkan selama 2 tahun konsumsi ARV.

	ix. Profilaksis kotrimoksazol juga diberikan secara rutin pada ODHIV dengan TBC aktif tanpa melihat jumlah CD4. Apabila pengobatan OAT selesai dan nilai CD4 >200 sel/μL, maka pemberian kotrimoksazol dapat dihentikan, tetapi apabila CD4 < 200 sel/μL, maka kotrimoksazol dapat diteruskan dengan dosis yang sama. x. Dokter atau petugas PDP akan memperkenalkan petugas pendamping, baik dari tim layanan maupun dari mitra komunitas untuk menawarkan pendampingan pengobatan dan dukungan psikososial. xi. Dokter meresepkan terapi ARV dan terapi lain sesuai kebutuhan medis klien. Kemudian Dokter/Perawat mengarahkan klien ke Ruang Farmasi untuk pengambilan obat ARV. xii. Untuk kunjungan pertama, Dokter memberikan klien terapi ARV selama 2 minggu atau 1 bulan, kemudian dilanjutkan pemberian selama 1 bulan konsumsi untuk setiap kunjungan berikutnya. xiii. Dokter/Perawat memberikan penjelasan bahwa pengobatan HIV merupakan pengobatan seumur hidup dan memerlukan kepatuhan minum obat sehingga perlu meminta persetujuan tertulis pasien (<i>inform consent</i> penelusuran kepada klien) bahwa dapat dilakukan tindakan penelusuran bila pasien tidak hadir atau mangkir selama pengobatan (Form sesuai lampiran 4). xiv. Dokter/perawat menawarkan notifikasi pasangan dan anak kepada klien. xv. Di Ruang Farmasi, Petugas Farmasi memberikan ARV dan edukasi kepada klien, meliputi: 1. Penjelasan mengenai tatalaksana pengobatan yang akan dijalani; 2. Pentingnya kepatuhan minum obat sesuai jadwal; 3. Informasi tentang efek samping yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya; 4. Penjelasan mengenai interaksi obat yang perlu dihindari; 5. Peningkat jadwal kontrol rutin untuk evaluasi terapi. xvi. Pada kunjungan ulang, Dokter atau petugas PDP lain akan menilai kepatuhan klien dalam meminum obat ARV. Jika ditemukan kendala yang mempengaruhi kepatuhan klien dalam pengobatan, petugas dan klien akan berdiskusi untuk mencari jalan keluar yang disepakati bersama. xvii. Pencatatan dan Pelaporan
--	--

	1. Petugas (Dokter/Perawat dan RR) akan menginput data klien ke dalam Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) 2.1: a. Tambah pasien baru, input NIK dan nama lengkap sesuai identitas asli (KTP); b. Verifikasi apakah klien sudah terdaftar sebelumnya di layanan PDP; c. Input permintaan pemeriksaan laboratorium oleh Dokter dan hasil tes (selanjutnya diisi oleh Petugas Laboratorium); d. Setelah hasil keluar, data dikirimkan ke Dokter untuk pembukaan status klien. e. Dokter menginputkan hasil diagnosis dari hasil pemeriksaan lab. f. Selain SIHA, data pemeriksaan dan hasil tes HIV juga akan diinput ke dalam rekam medis elektronik layanan. 2. Dokter menginputkan resep obat yang diberikan kepada klien sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan. 3. Petugas farmasi mengecek resep obat dan menginputkan status pemberian obat kepada klien. c. Pemantauan Setelah Pemberian Terapi ARV i. Dokter/Perawat melakukan pemantauan secara klinis dan laboratorium secara rutin selama klien dalam terapi ARV. ii. Pemantauan kepatuhan minum obat (<i>adherence</i>) dilakukan setiap bulan menggunakan metode <i>pill count</i>. Berikut kategori tingkat <i>adherence</i>. 1. <i>Adherence</i> >95% jika <3 dosis yang lupa diminum dalam 30 hari, atau kepatuhan baik; 2. <i>Adherence</i> 80-95% jika 3-12 dosis yang lupa diminum dalam 30 hari, atau kepatuhan sedang. 3. <i>Adherence</i> <80% jika >12 dosis yang lupa diminum dalam 30 hari, atau kepatuhan buruk. iii. Pemantauan efek samping obat dilakukan dengan cara anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Dimulai pada minggu ke-2 setelah pemberian terapi ARV, dilanjutkan 1 bulan, 3 bulan kemudian dan selanjutnya tiap 3 bulan atau jika diperlukan. 1. Pemeriksaan kreatinin dilakukan setiap 6 bulan pada klien yang menggunakan Tenofovir. 2. Pemeriksaan Hb dilakukan setiap 6 bulan pada klien yang menggunakan Zidovudin.
--	---

- iv. Dokter juga melakukan pemantauan respon terapi dan penentuan kegagalan terapi ARV terhadap klien, dengan menggunakan standar emas melalui jumlah virus atau nilai *Viral load* (VL) dimulai dari 6 bulan setelah pemberian ARV, kemudian bulan ke-12, dan selanjutnya dilakukan rutin setiap tahun.
- v. Dokter menentukan tindak lanjut setelah menerima hasil tes VL sesuai dengan alur berikut :



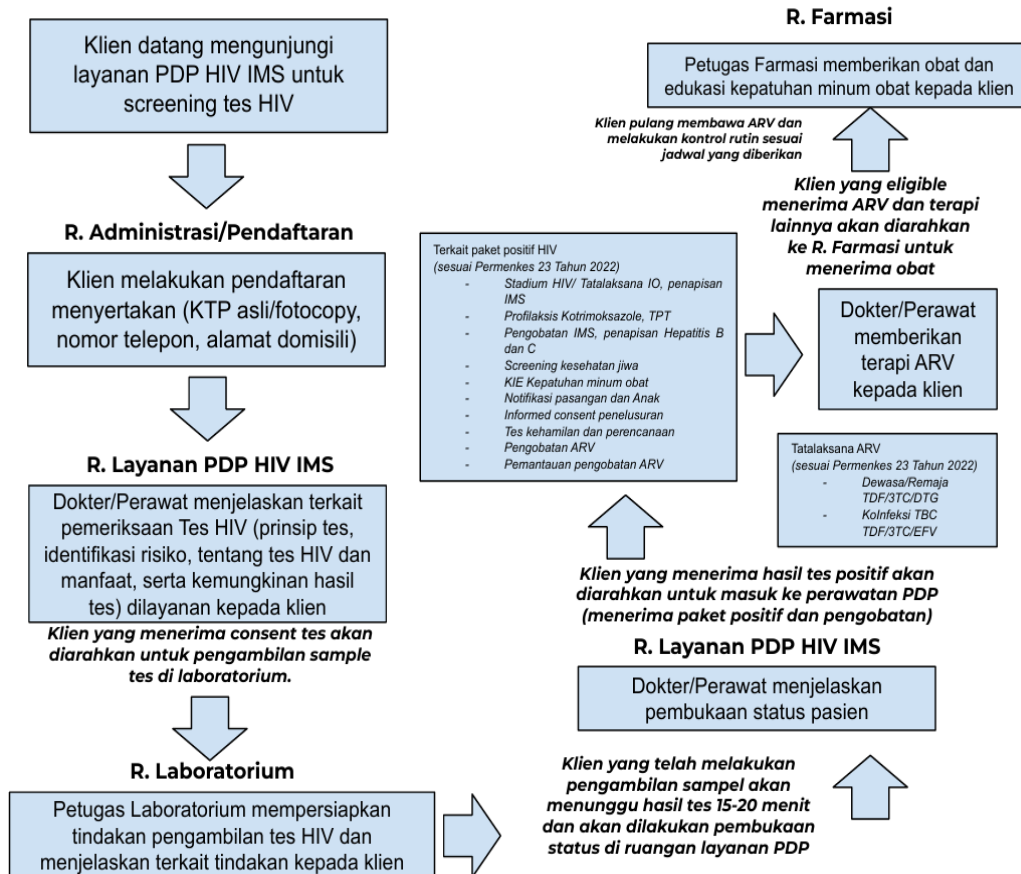
****)** *Pemeriksaan VL dengan hasil > 1000 kopi/ml disimpulkan pengobatan tidak berhasil (tidak tersupresi) dan perlu diulang 3 bulan lagi dengan konseling dan perbaikan kepatuhan pengobatan. Pemeriksaan ulang pada kondisi ini juga ditanggung oleh program (Kementerian Kesehatan RI)*

- vi. Dokter melakukan penggantian regimen ARV (*Switch*) ke lini selanjutnya dilakukan jika virus tidak tersupresi dengan pemberian obat ARV atau terjadi kegagalan pengobatan (gagal terapi) dengan syarat pengobatan ARV telah berlangsung selama 6 bulan dan kepatuhan minum obat yang tinggi, setelah memenuhi kriteria gagal terapi sesuai tabel berikut :

GAGAL VIROLOGIS	
Viral Load >1000 kopi/mL berdasarkan pemeriksaan 2 kali berur dengan interval 3 bulan, dengan dukungan <i>adherence</i> yg baik se pemeriksaan VL pertama, setelah paling sedikit iniasisi ART 6 bulan	
GAGAL IMUNOLOGIS	
Dewasa dan Remaja	Anak-anak
Jumlah CD4 <250 sel/mm ³ setelah gagal klinis atau CD4 persisten <100 sel/mm ³	<5 tahun: CD4 persisten <200 sel/mm ³ ≥5 tahun: CD4 persisten <100 sel/mm ³
GAGAL KLINIS	
Dewasa dan Remaja	Anak-anak
Munculnya IO baru atau berulang yang mengindikasikan defisiensi imun berat setelah 6 bulan pengobatan yang efektif	Munculnya IO baru atau berulang yang mengindikasikan defisiensi im berat atau lanjut setelah 6 bulan pengobatan yang efektif

***) Alur pelayanan TBC HIV pada ODHIV termasuk didalamnya mencakup pemeriksaan diagnosa TBC dan pemberian OAT pada ODHIV terdiagnosa TBC akan menyesuaikan ketersediaan layanan kolaborasi TBC - HIV, dengan skenario seperti terlihat pada Lampiran 5.

Bagan Alur



Unit terkait

1. Poli KIA, Poli TBC, Poli Umum, IGD, dan unit terkait lainnya
2. Mitra Komunitas Penjangkau dan Mitra Komunitas Pendamping
3. Kader Kesehatan
4. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat